

Reporte Técnico de Curación de Datos para Arquitectura RAG: Sistema de Triage Psiquiátrico MenteSalud

La intersección entre la inteligencia artificial generativa y la salud mental clínica exige una arquitectura de datos que subordine la capacidad predictiva de los modelos de lenguaje de gran escala (LLM) a un corpus documental estrictamente validado, legalmente vinculante y médicamente preciso. El presente análisis exhaustivo detalla la curaduría, evaluación y estrategia de vectorización de los documentos técnicos seleccionados para alimentar el sistema de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) de la plataforma MenteSalud. Este sistema ha sido diseñado para operar como una primera línea de triage psicológico, contención emocional aguda y derivación estructurada, con un enfoque prioritario en la población de Argentina y Latinoamérica.

A diferencia de los enfoques tradicionales de procesamiento de lenguaje natural, la arquitectura RAG mitiga el riesgo inherente de alucinaciones al forzar al modelo a anclar sus respuestas en fragmentos de texto (chunks) recuperados semánticamente de una base de datos vectorial¹. Por consiguiente, la idoneidad de los documentos fundacionales —su jerarquía de títulos, la claridad de sus esquemas condicionales y la densidad de su texto nativo— determina de manera directa la precisión clínica de las inferencias generadas³.

La selección documental se ha estructurado rigurosamente en cuatro dimensiones operativas fundamentales: la estandarización de los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), la algoritmia de derivación mediante árboles de triage, la instrumentación de técnicas de estabilización aguda y la consolidación de los marcos legales y directorios de recursos aplicables.

Protocolos de Crisis y PAP

El módulo de Protocolos de Crisis y Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) constituye el núcleo de la intervención de primera instancia del sistema. Los PAP no equivalen al asesoramiento psicoterapéutico ni a una intervención clínica prolongada; son técnicas de apoyo humanitario orientadas a brindar alivio emocional inmediato, proteger a la persona de estrés adicional, facilitar la adaptación y prevenir el desarrollo de psicopatologías severas como el trastorno por estrés postraumático⁵. El motor RAG requiere instrucciones secuenciales precisas para modular el tono de la interacción generada y aplicar directrices conversacionales específicas que eviten el daño iatrogénico.

Categoría: Protocolos de Crisis y PAP Título del Documento y Emisor: Guía de Intervención mhGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias (Versión 2.0) - Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Enlace Directo al PDF:

http://www.sesegob.mx/assets/img/salud-mental/GUIA_mhGAP_2.0.pdf Idoneidad para RAG (1-10): 8 Secciones Clave a Extraer: Principios Generales de la Atención (APE) en las páginas 5 a 15; Módulo de Depresión (DEP) en las páginas 19 a 32; Módulo de Psicosis (PSI) en las páginas

33 a 50; Módulo de Autolesión/Suicidio (SUI) en las páginas 131 a 140.

La Guía mhGAP representa el estándar internacional supremo para la atención de la salud mental en niveles no especializados y ha sido ampliamente adoptada por los ministerios de salud en toda América Latina⁸. La idoneidad técnica del documento se sitúa en un nivel alto debido a su diseño algorítmico, el cual emplea diagramas de flujo estructurados en tres columnas fundamentales: "Evaluar, Decidir y Manejar"¹. Esta estructura condicional es ideal para la recuperación semántica, ya que permite al sistema RAG trazar vectores lógicos frente a los síntomas descritos por el usuario. No obstante, la complejidad inherente de las tablas requiere que el proceso de ingesta (chunking) utilice analizadores avanzados orientados a la estructura, como LlamaParse o segmentadores de Markdown, para evitar que la división de tokens quiebre la continuidad del razonamiento clínico entre la evaluación de un síntoma y su manejo correspondiente¹.

Dentro de la arquitectura de MenteSalud, el módulo de Autolesión/Suicidio (SUI) actuará como un mecanismo de interrupción de máxima prioridad (guardrail). La guía establece transversalmente que, ante cualquier indicio de riesgo suicida inminente, el protocolo de evaluación de otros trastornos (como la depresión o la epilepsia) debe suspenderse inmediatamente para priorizar el manejo de la emergencia vital⁸. Esta directriz instruirá al orquestador del LLM para que, al detectar similitud semántica con ideación autolítica, desvíe el flujo conversacional hacia la contención aguda y la derivación hospitalaria.

Categoría: Protocolos de Crisis y PAP Título del Documento y Emisor: Manual ABCDE para la aplicación de Primeros Auxilios Psicológicos - Pontificia Universidad Católica de Chile y Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN). Enlace Directo al PDF: https://www.preventionweb.net/files/59897_auxiliar.pdf?startDownload=true
Idoneidad para RAG (1-10): 9 Secciones Clave a Extraer: Etapa de Preparación en las páginas 10 y 11; Protocolo ABCDE y Escucha Activa en la página 12; Reentrenamiento de la Ventilación en la página 15; Cuadro Resumen en la página 28.

El Manual ABCDE operacionaliza los Primeros Auxilios Psicológicos mediante un acrónimo secuencial altamente asimilable por modelos de procesamiento de lenguaje natural: Escucha Activa, Ventilación, Categorización de Necesidades, Derivación a redes y Psicoeducación¹⁰. Este nivel de estandarización es invaluable para el sistema RAG, ya que proporciona reglas conversacionales directas que el LLM puede adoptar como directrices de comportamiento (System Prompts) en tiempo real.

El documento se destaca por incluir instrucciones binarias sobre actitudes recomendadas y contraindicadas. Por ejemplo, prohíbe explícitamente el uso del denominado "lenguaje emocional" invasivo (preguntar incesantemente por qué el usuario siente algo) y advierte contra el "furor curandis", un impulso irreflexivo por ofrecer soluciones precipitadas a quien está sufriendo⁵. La extracción de la página 15, que detalla el reentrenamiento de la ventilación mediante inspiraciones y exhalaciones pautadas en cuatro tiempos, permitirá a la plataforma ofrecer un guion interactivo estructurado cuando el análisis de sentimiento del texto de entrada detecte hiperactivación simpática o desborde emocional inminente¹⁰.

Categoría: Protocolos de Crisis y PAP Título del Documento y Emisor: Orientaciones técnicas para el fortalecimiento de los Primeros Auxilios Psicológicos como herramienta de cuidado en

salud mental - Ministerio de Salud de Colombia. Enlace Directo al PDF: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/orientaciones-tecnicas-fortalecimiento-pap-herramienta-salud-mental.pdf> Idoneidad para RAG (1-10): 8 Secciones Clave a Extraer: Principales Objetivos e Identificación en las páginas 12 a 15; Delimitación negativa (Lo que NO son los PAP) en la página 16; Pasos de Intervención en las páginas 18 a 22. Este documento complementa el corpus aportando una delimitación deontológica estricta sobre los alcances de la intervención primaria. Al extraer la sección dedicada a lo que no constituyen los PAP, el sistema RAG incorpora restricciones legales que impiden que el LLM intente realizar diagnósticos psiquiátricos, ofrezca asesoramiento terapéutico formal o presione al usuario para que relate experiencias traumáticas⁷. La segmentación de este documento en la base de datos vectorial enriquecerá los nodos de conocimiento asociados a la provisión de seguridad, la evaluación de necesidades básicas y la empatía activa, garantizando que las respuestas generadas se mantengan estrictamente dentro de los límites de la asistencia humanitaria y la contención emocional transitoria⁷.

Criterios de Derivación (Árboles de Triage)

La precisión en la clasificación del riesgo es la función más crítica de la plataforma MenteSalud. El sistema debe poseer la capacidad algorítmica para discernir entre una emergencia psiquiátrica inminente —que exige la activación de un Código Rojo y la derivación perentoria a una guardia hospitalaria— y una urgencia subjetiva categorizada como Código Verde, la cual puede ser manejada mediante contención en línea y derivación ambulatoria diferida. Para lograr este nivel de discriminación, el motor RAG debe alimentarse de matrices de clasificación de riesgo (escalas de triage) convalidadas internacionalmente y adaptadas a la realidad sanitaria local.

Categoría: Criterios de Derivación (Árboles de Triage) Título del Documento y Emisor: Protocolo Provincial de Manejo Inicial de las Urgencias de Salud Mental - Ministerio de Salud y Deportes, Gobierno de la Provincia de Mendoza. Enlace Directo al PDF:

<https://www.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/7/2024/06/PROTOCOLO-PROVINCIAL-DE-MANEJO-INICIAL-DE-LAS-URGENCIAS-DE-SALUD-MENTAL-MENDOZA.pdf> Idoneidad para RAG (1-10): 9 Secciones Clave a Extraer: Triage de Salud Mental y Sistema de Clasificación por Colores (Anexo 1) a partir de la página 13.

Este protocolo, actualizado en 2024, introduce una estratificación del riesgo psiquiátrico basada en cinco niveles de urgencia (codificados por colores), lo que lo convierte en un marco ontológico excepcional para la traducción algorítmica. La vectorización de este anexo permitirá al LLM ponderar el nivel de gravedad de los síntomas ingresados por el usuario, asociándolos de forma determinista con tiempos de atención esperados y acciones de derivación¹¹.

La estructuración de los datos extraídos para la recuperación semántica se organizará conceptualmente de la siguiente manera:

Nivel de Triage	Tiempo Máximo	Condición Clínica y Casos Típicos para
-----------------	---------------	--

		Detección Algorítmica
Código Rojo	Inmediato	Riesgo orgánico inminente, síndrome confusional agudo, intoxicaciones graves, autolesiones severas con compromiso vital ¹¹ .
Código Naranja	Hasta 10 minutos	Excitación psicomotriz (EPM), agresividad física/verbal manifiesta, intento de suicidio reciente, riesgo autolítico inminente ¹¹ .
Código Amarillo	Hasta 30 minutos	Ideación suicida activa sin plan inminente, ataques de pánico en curso, alteraciones conductuales disruptivas, presencia de alucinaciones o ideas delirantes ¹¹ .
Código Verde	Hasta 60 minutos	Sintomatología de ansiedad moderada, episodios depresivos sin ideación suicida, urgencias sin compromiso vital inminente ¹¹ .
Código Azul	Hasta 120 minutos	Urgencias subjetivas generales, demandas administrativas, vulnerabilidad social sin indicadores de riesgo clínico ¹¹ .

Al mapear las consultas de los usuarios contra esta matriz vectorial, el sistema MenteSalud podrá aplicar umbrales de seguridad predefinidos. Si las incrustaciones (embeddings) del texto del usuario reflejan una similitud semántica alta con los descriptores del Código Naranja o Rojo,

el sistema anulará el flujo de conversación estándar y forzará la visualización de los directorios de emergencia locales.

Categoría: Criterios de Derivación (Árboles de Triage) Título del Documento y Emisor: Modelos de Triage en Salud Mental - Publicación Científica de Enfermería de Urgencias. Enlace Directo al PDF:

<https://enfermeriadeurgencias.org/wp-content/uploads/MODELOS-DE-TRIAJE-EN-SALUD-MENTAL.pdf> Idoneidad para RAG (1-10): 9 Secciones Clave a Extraer: Modelo Australiano (Australasian Triage Scale Mental Health) en las páginas 2 y 3; Modelo Canadiense (CTAS) en las páginas 3 y 4; Sistema Español de Triage (SET) y Modelo Manchester en las páginas subsecuentes.

La integración de escalas internacionales validadas provee al modelo fundacional de una heurística universal para el análisis de riesgo. El Modelo Australiano (ATS), por ejemplo, clasifica a los pacientes con problemas de salud mental en cinco niveles, enfocándose meticulosamente en el riesgo inmediato de daño a sí mismo o a terceros y en el grado de desorden conductual¹². Paralelamente, el Modelo Manchester (MTS) utiliza discriminadores clave como la letalidad de la autolesión, el nivel de angustia acusada y la presencia de historias psiquiátricas previas para condicionar la decisión de triage¹².

La idoneidad de este documento es excepcionalmente alta debido a su formato de listas y categorías discretas, las cuales se fragmentan limpiamente durante el proceso de división de texto (text splitting). El sistema RAG utilizará estos modelos comparativos en el plano de fondo para refinar la comprensión del LLM sobre la peligrosidad latente en descripciones ambiguas, como la ideación suicida sin agitación efectiva (clasificada generalmente como Nivel 3 o 4 dependiendo de las constantes asociadas)¹².

Categoría: Criterios de Derivación (Árboles de Triage) Título del Documento y Emisor: Guía para la Exploración Clínica y Escala SAD PERSONS - Compilación de Protocolos Hospitalarios.

Enlaces Directos a los PDF:

- <https://psiquiatria.com/congresos/pdf/1-8-2021-149-PON15.pdf>
- <https://www.hospitalsanfranciscocodepucon.cl/wp-content/uploads/2023/04/GCL-1.10-PROTOCOLO-CRITERIOS-DE-INGRESO-EGRESO-Y-DERIVACION-PACIENTES-CON-INTENTO-SUICIDA-RAC-listo-impresio.pdf> Idoneidad para RAG (1-10): 8 Secciones Clave a Extraer: Escala de valoración de riesgo suicida SAD PERSONS, indicadores de letalidad y puntuación de ingreso hospitalario obligatorio.

La evaluación del riesgo suicida exige herramientas objetivas y mnemotécnicas. La escala SAD PERSONS es un instrumento clínico extensamente validado que evalúa diez factores de riesgo independientes para predecir la inminencia del acto suicida y justificar el ingreso hospitalario¹³. Al vectorizar esta escala, el sistema MenteSalud adquiere la capacidad de estructurar entrevistas de recolección de datos guiadas por parámetros médicos precisos.

Letra (Acrónimo)	Factor de Riesgo Evaluado	Implicación en el Sistema de Triage RAG
------------------	---------------------------	---

S (Sex)	Sexo masculino	Aumenta estadísticamente la letalidad del intento ¹³ .
A (Age)	Edad < 20 o > 45 años	Identificador demográfico de vulnerabilidad aumentada ¹³ .
D (Depression)	Diagnóstico de depresión	Incrementa la ponderación de severidad clínica ¹³ .
P (Previous Attempt)	Intento de suicidio previo	Predictor fundamental; activa la recuperación de antecedentes ¹³ .
E (Ethanol Abuse)	Abuso de alcohol o sustancias	Disminuye la inhibición y requiere filtro de guardia toxicológica ¹³ .
R (Rational thinking loss)	Pérdida de pensamiento racional	Indicador de psicosis o desconexión; requiere código de urgencia elevado ¹³ .
S (Social Support lacking)	Ausencia de soporte social	Justifica la imposibilidad de un tratamiento ambulatorio seguro ¹³ .
O (Organized plan)	Plan estructurado para suicidarse	Alerta máxima; se asocia a un 32% de probabilidad de consumación inminente ¹³ .
N (No spouse)	Falta de pareja o aislamiento	Factor de vulnerabilidad vincular y ambiental ¹³ .
S (Sickness)	Enfermedad médica crónica o grave	Agravante psicosomático que requiere atención integral ¹³ .

El diseño del RAG instruirá al LLM a calcular implícitamente esta puntuación (donde 0-2 indica

riesgo bajo, 3-4 riesgo moderado, 5-6 riesgo alto, y 7-10 ingreso obligado) basándose en las interacciones del usuario, objetivando así la justificación de la derivación y minimizando el sesgo algorítmico¹³.

Categoría: Criterios de Derivación (Árboles de Triage) Título del Documento y Emisor: Guía de Atención en la Crisis y Urgencias en Hospitales Generales - Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (2022). Enlace Directo al PDF:

<https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/saludmental/files/2022/08/GUIA-DE-ATENCION-EN-LA-CRISIS-Y-URGENCIAS-EN-HOSPITALES-GENERALES-DE-LA-PROVINCIA-DE-BUENOS-AIRES.pdf>

Idoneidad para RAG (1-10): 8 Secciones Clave a Extraer: Modalidad de abordaje de las urgencias (páginas 8 a 15); Criterios de uso y contraindicaciones de la sujeción mecánica / contención física.

Esta guía jurisdiccional resulta indispensable para parametrizar las intervenciones frente a excitaciones psicomotrices severas. Aunque la plataforma MenteSalud es un entorno virtual, el conocimiento incorporado sobre la sujeción mecánica (que debe utilizarse exclusivamente cuando han fallado otras medidas, nunca como castigo, y garantizando el monitoreo continuo para evitar lesiones o asfixia) permite que el sistema brinde orientaciones técnicas precisas a familiares, personal de seguridad o técnicos de la salud que consulten el sistema desde un entorno de guardia¹⁷.

El documento establece además que las crisis no son eventos aislados, sino emergentes dentro del proceso continuo de salud-enfermedad, requiriendo un abordaje que considere los determinantes socioeconómicos y los lazos comunitarios del individuo¹⁷. Este enfoque instruirá al modelo a indagar sobre el contexto social y los desencadenantes ambientales antes de emitir una recomendación de triage¹⁷.

Psicoeducación Breve y Estabilización

La estabilización emocional representa el pilar terapéutico para aquellos usuarios que el sistema clasifica dentro de los códigos de urgencia baja (Verde o Azul). Frente a manifestaciones de ansiedad paroxística, hiperactivación neurovegetativa o desrealización que no conllevan riesgo para la vida, el modelo RAG debe estar capacitado para ofrecer intervenciones psicoeducativas breves, estructuradas y basadas en evidencia empírica que faciliten la autorregulación.

Categoría: Psicoeducación Breve y Estabilización Título del Documento y Emisor: En tiempos de estrés, haz lo que importa: una guía ilustrada (Versión adaptada para América Latina) - OMS y OPS (2022). Enlace Directo al PDF:

<https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/4dc24a-EntiemposdeestrshazloqueimportaversionamericalatinaOPS.pdf>

Idoneidad para RAG (1-10): 7 Secciones Clave a Extraer: Parte 1 (Poner los pies en la tierra / Grounding) en las páginas 11 a 15; Técnica de la Bebida Caliente (mindfulness) en la página 8; Estrategias para desengancharse de las tormentas emocionales.

Esta publicación de la OMS constituye un protocolo validado a nivel mundial que fundamenta sus intervenciones en los principios de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)¹⁸. La obra conceptualiza los episodios de crisis de ansiedad extrema como "tormentas emocionales", proponiendo que el individuo debe anclarse (poner los pies en la tierra) para evitar ser

arrastrado por la evitación experiencial y la fusión cognitiva¹⁸.

La calificación de idoneidad desciende a 7 debido a la naturaleza multimodal del PDF, el cual depende fuertemente de ilustraciones gráficas para transmitir su mensaje. La ingesta de datos requerirá la implementación de herramientas de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) o modelos de visión para extraer el texto incrustado. Sin embargo, el valor clínico de los fragmentos recuperados es incalculable. La extracción de las páginas 11 a 15 proporcionará al LLM un guion paso a paso para guiar a los usuarios: notar los pensamientos, bajar el ritmo respiratorio exhalando lentamente, presionar los pies firmemente contra el suelo o estirarse, y finalmente reconectar los sentidos con el entorno²⁰. De igual manera, el ejercicio de la bebida caliente enseñará al sistema cómo instruir al usuario para que dirija su atención plena hacia el olor, la temperatura y el sabor de un estímulo cotidiano, mitigando la disociación¹⁹.

Categoría: Psicoeducación Breve y Estabilización Título del Documento y Emisor: Cartillas Clínicas de Técnica de Grounding 5-4-3-2-1 - UC Resource Center y Universidad de Monterrey. Enlaces Directos a los PDF:

- <https://ucresourcecenter.org/wp-content/uploads/2024/04/Tecnica-de-Grounding-5-4-3-2-1-1.pdf>
- <https://www.udem.edu.mx/sites/default/files/2022-10/Grounding-una-forma-diferente-de-disminuir-el-estr%C3%A9s.pdf> Idoneidad para RAG (1-10): 10 Secciones Clave a Extraer: El contenido íntegro de ambas cartillas, focalizándose en el inventario sensorial secuencial (5 cosas que ver, 4 que tocar, 3 que escuchar, 2 que oler, 1 que saborear).

La técnica de enraizamiento sensorial (grounding) 5-4-3-2-1 es uno de los recursos empíricos más rápidos y efectivos para contrarrestar la desregulación de la amígdala durante ataques de pánico o crisis de angustia inmanejable²¹. Al obligar a la corteza cerebral a procesar estímulos ambientales tangibles, la técnica inhibe las cascadas de ansiedad intrusiva²¹.

La idoneidad de estos documentos es perfecta (10) debido a su formato de listas cortas, jerárquicas y directas. En la arquitectura de chunking, se recomienda mantener la técnica completa dentro de un único vector semántico, evitando fracturar los pasos mediante segmentadores de texto convencionales. Cuando el motor de clasificación semántica detecte descriptores como "sensación de irrealidad", "corazón acelerado" o "no puedo respirar", el sistema recuperará intacta la secuencia 5-4-3-2-1, permitiendo que el LLM actúe como un facilitador dinámico que guíe al paciente a través de cada fase sensorial en tiempo real²¹.

Directorio de Recursos y Marcos Legales Base

La arquitectura de un sistema de salud autónomo exige la integración de salvaguardas (guardrails) legales inexorables que rijan su comportamiento, particularmente en el sensible ámbito de la psiquiatría civil y los derechos humanos. Simultáneamente, el triage carece de utilidad clínica si no culmina en una acción concreta, lo que requiere la asimilación de directorios geolocalizados y actualizados de los efectores de salud.

Categoría: Directorio de Recursos y Marcos Legales Base Título del Documento y Emisor: Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y Lineamientos para la Atención de la Urgencia en Salud Mental - Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Enlaces Directos a los PDF:

- <https://www.mpd.gov.ar/uploads/documentos/Ley%2026657.pdf>

- <https://www.psicologosgcaba.org.ar/wp-content/uploads/Lineamientos-atencion-urgencia-en-salud-mental.pdf> Idoneidad para RAG (1-10): 10 y 9 respectivamente. Secciones Clave a Extraer: Ley 26.657: Capítulo IV (Derechos de las personas con padecimiento mental), Capítulo VII (Internaciones, Artículos 14 al 25). Lineamientos MSAL: Capítulos 6 y 7 sobre estrategias terapéuticas inmediatas, pautas de urgencia y criterios de internación.

La Ley Nacional de Salud Mental 26.657 consolida un cambio de paradigma insoslayable en Argentina, fundamentando la atención en la presunción de capacidad jurídica de todas las personas, la prohibición de creación de nuevas instituciones monovalentes (manicomios) y la promoción de la atención comunitaria y descentralizada²³. El sistema RAG debe incorporar escrupulosamente los preceptos vinculados al consentimiento informado y a las restricciones de la privación de libertad²³.

El concepto legal más crítico a vectorizar es la definición operativa de "Riesgo Cierto e Inminente", la cual constituye la única justificación legal admisible para autorizar una internación involuntaria⁴. Según la normativa y los lineamientos del Ministerio de Salud, este riesgo se entiende como la contingencia o proximidad de un daño seguro e indubitable a la vida o integridad de la persona o de terceros, cuya determinación recae invariablemente en una evaluación interdisciplinaria actual⁴. Al ingerir estos textos utilizando un segmentador basado en expresiones regulares (Regex) ajustado a las palabras "ARTICULO" o "Capítulo", la base de datos vectorial mantendrá la coherencia de cada mandato legal. Esto impedirá que el modelo sugiera internaciones forzosas contrarias a derecho y guiará al usuario sobre sus garantías fundamentales (e.g., el derecho a asistencia letrada durante una internación o la obligatoriedad de notificar al Órgano de Revisión)³.

Categoría: Directorio de Recursos y Marcos Legales Base Título del Documento y Emisor: Ley Nacional N° 27.130 (Prevención del Suicidio) y Protocolos de Redes Universitarias/OSCOEMA.

Enlaces Directos a los PDF:

- <http://www.oscoema.com.ar/images/portada/suicidio.pdf>
- <https://uner.edu.ar/archivos/guia-salud-mental.pdf> Idoneidad para RAG (1-10): 10 Secciones Clave a Extraer: Directorios de líneas telefónicas nacionales gratuitas (135, 0800 Nacional), principios de atención biopsicosocial y postvención establecidos por la ley.

La Ley Nacional de Prevención del Suicidio declara de interés nacional la atención biopsicosocial, la capacitación y la asistencia a las familias frente al riesgo autolítico²⁸. Los documentos complementarios aportan las líneas vitales estandarizadas a nivel federal. La recuperación de estos metadatos es prioritaria; ante cualquier similitud cosenoidal detectada en el espacio vectorial con términos como "suicidio" o "muerte", el orquestador del sistema debe forzar la inyección en pantalla del número 135 (Centro de Asistencia al Suicida) y el 0800-345-1435 para alcance nacional, acompañados de las directrices de contención emocional³⁰.

Categoría: Directorio de Recursos y Marcos Legales Base Título del Documento y Emisor: Guía de Recursos de Salud Mental y Adicciones - Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Febrero/Septiembre 2024). Enlace Directo al PDF:

<https://defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2024/09/Guia-de-Recursos-de-Salud-Mental-y-Adicciones.pdf> Idoneidad para RAG (1-10): 8 Secciones Clave a Extraer: Listado integral de Hospitales Generales de Agudos, Hospitales Especializados, Centros de Salud Mental (CSM), Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC), y Líneas de Emergencia Directa.

La culminación operativa del triage es la interconexión con la red de salud física. La Guía de Recursos de CABA ofrece la cartografía de asistencia para el distrito de mayor densidad poblacional del país, la cual debe ser transformada e ingerida en formato de diccionario estructurado (clave-valor) para garantizar una derivación precisa³².

La vectorización de este directorio habilitará al LLM para geolocalizar y derivar según la necesidad clínica identificada, utilizando datos estructurados similares a los siguientes:

Dispositivo / Nivel de Atención	Línea Telefónica	Especialidad / Alcance Clínico
Salud Mental Responde	0800-333-1665	Contención 24hs y orientación a la red de servicios (Baja/Media urgencia) ³² .
SAME Psiquiátrico	107	Respuesta de emergencia prehospitalaria y traslado (Código Rojo/Naranja) ³² .
Atención en Adicciones (DGPSA)	108 (opción 3)	Derivación a Centros de Admisión (ASA) y dispositivos territoriales de consumo problemático ³² .
Hospitales Especializados	Borda: 4304-5498 Moyano: 4301-6500 Alvear: 4521-5555	Abordaje interdisciplinario de cuadros psiquiátricos severos en etapa aguda ³² .
Hospitales Generales de Agudos	Álvarez: 4630-2900 Pirovano: 4546-4300 Fernández: 4808-2600	Guardias interdisciplinarias 24hs recomendadas por la Ley 26.657 para desestigmatizar la internación ⁴ .

Hospitales Generales de Niños	Ricardo Gutiérrez: 4962-9247 Elizalde: 4363-2100	Diagnóstico, internación y tratamiento exclusivo para población pediátrica e infantojuvenil ³² .
Atención Primaria Comunitaria	CSM (1 y 3) y CeSACs (1 al 48)	Atención ambulatoria, prevención y seguimiento post-crisis (Códigos Verdes/Azules) ³² .

Al disponer de esta topología sanitaria en su base de conocimiento vectorial, MenteSalud trasciende la mera clasificación teórica. Si un usuario reporta una urgencia toxicológica aguda, el sistema priorizará la recuperación de los datos de contacto de la línea 108 (opción 3) y de las guardias generales más cercanas, cumpliendo íntegramente con los postulados de la ley de salud mental¹⁷.

Síntesis Arquitectónica y Conclusiones

La implementación del sistema RAG MenteSalud, nutrida por el corpus documental delineado en este informe, establece una ontología de datos capaz de sostener intervenciones automatizadas con riguroso respaldo biomédico y jurídico. El diseño del espacio vectorial deberá segmentarse de manera estricta para prevenir la contaminación semántica; es decir, separar los fragmentos correspondientes a los *Protocolos Clínicos de Triage* (como las escalas SAD PERSONS o el modelo ATS) de los *Protocolos de Psicoeducación* (grounding 5-4-3-2-1) y del *Corpus Legal Constitutivo* (Ley 26.657 y Lineamientos MSAL)¹².

Esta partición modular garantiza que la recuperación de la información (retrieval) dependa del nivel de severidad detectado por el clasificador de intenciones durante la fase de procesamiento de entrada. Cuando el sistema enfrente cuadros de excitación severa o riesgo inminente, el embudo de atención priorizará el encuadre ético de la internación involuntaria y la inyección expedita de los directorios de emergencia del SAME o del Centro de Asistencia al Suicida¹⁷. Por el contrario, ante urgencias subjetivas o crisis de ansiedad sin riesgo orgánico o vital, la arquitectura orquestará las guías de respiración en cuatro tiempos, estabilizando al paciente mientras se coordina una derivación ambulatoria¹⁰. En última instancia, la curaduría algorítmica y documental expuesta transforma la inteligencia artificial generativa en un vector de acceso equitativo, escalable y responsable a la salud mental.

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional.

Obras citadas

1. Guía de Intervención mhGAP - MinSalud,
<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/INTOR/gui-a-intervencion-mh-gap.pdf>
2. Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes,

- https://interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/migrated/2019-03/ia_sc_guidelines_mhpss_spanish.pdf
3. Protocolo de atención en situaciones de crisis y/o urgencia en salud mental, <http://observatoriosmyddhh.org/wp-content/uploads/2021/07/Protocolo-de-atencion-en-situaciones-de-crisis-y-o-urgencia-en-salud-mental.pdf>
 4. <https://www.psicologosgcaba.org.ar/wp-content/uploads/Lineamientos-atencion-urgencia-en-salud-mental.pdf>
 5. Guía de Primeros Auxilios Psicológicos y Apoyo Psicosocial para primeros respondientes SARS CoV-2 / COVID-19, https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2020/07/GU%C3%8DA-PAP-COVID-19_2020.pdf
 6. EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES: CARACTERÍSTICAS DE LAS INTERVENCIONES DE PRIMERA RESPUESTA: “Primeros Auxilios Psicológicos/ Emocionales” - UBA, https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/070_psicoterapias1/material/emergencias_catastrofes.pdf
 7. Orientaciones técnicas - MinSalud, <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/orientaciones-tecnicas-fortalecimiento-pap-herramienta-salud-mental.pdf>
 8. Guía de intervención mhGAP - Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, http://www.sesegob.mx/assets/img/salud-mental/GUIA_mhGAP_2.0.pdf
 9. Implementación del Programa de acción mundial para superar las brechas en salud mental - mhGAP - PAHO IRIS, <https://iris.paho.org/bitstreams/12fff971-e7c5-4c15-91e4-4653d09a16c9/download>
 10. Manual ABCDE para la - PreventionWeb.net, https://www.preventionweb.net/files/59897_auxiliar.pdf?startDownload=true
 11. PROTOCOLO PROVINCIAL DE ABORDAJE INICIAL DE LAS URGENCIAS DE SALUD MENTAL - Gobierno de Mendoza, <https://www.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/7/2024/06/PROTOCOLO-PROVINCIAL-DE-MANEJO-INICIAL-DE-LAS-URGENCIAS-DE-SALUD-MENTAL-MENDOZA.pdf>
 12. modelos de triaje en salud mental - Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias, <https://enfermeriadeurgencias.org/wp-content/uploads/MODELOS-DE-TRIAJE-EN-SALUD-MENTAL.pdf>
 13. manejo en urgencias del paciente suicida, ¿cuándo son “altables” los - Psiquiatría.com, <https://psiquiatria.com/congresos/pdf/1-8-2021-149-PON15.pdf>
 14. CRITERIOS DE INGRESO, EGRESO Y DERIVACIÓN DE PACIENTES CON INTENTO DE SUICIDIO, https://www.hospitalsanfranciscodepucon.cl/wp-content/uploads/2023/04/GCL-1_10-PROTOCOLO-CRITERIOS-DE-INGRESO-EGRESO-Y-DERIVACION%CC%81N-PACIENTES-CON-INTENTO-SUICIDA-RAC-listo-impresio%CC%81n.pdf
 15. Hojas Clínicas de Salud Mental - 5 Evaluación del Riesgo de Suicidio - UBA, https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/electivas/616_psicofarmacologia/material/evaluacion.pdf

16. Urgencias y emergencias - Ciencia Sanitaria,
<https://cienciasanitaria.es/wp-content/uploads/2022/09/URGENCIAS-OCTUBRE-2019-TOMO-II.pdf>
17. guía de atención de crisis y urgencias por motivos de salud mental y consumos problemáticos - Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires,
<https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/saludmental/files/2022/08/GUIA-DE-ATENCION-EN-LA-CRISIS-Y-URGENCIAS-EN-HOSPITALES-GENERALE-DE-LA-PROVINCIA-DE-BUENOS-AIRES.pdf>
18. “EN TIEMPOS DE ESTRÉS, HAZ LO QUE IMPORTA” - BVS,
<https://docs.bvsalud.org/biblioref/2025/02/1573055/orientaciones.pdf>
19. En tiempos de estrés, haz lo que importa: Una guía ilustrada - World Health Organization (WHO),
<https://www.who.int/docs/default-source/mental-health/sh-2020-spa-3-web.pdf>
20. ESTRÉS, - Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social,
<https://www.mspbs.gov.py/dependencias/porta/adjunto/4dc24a-EntiemposdeestershazloqueimportaversionamericalatinaOPS.pdf>
21. Grounding: Una forma diferente de disminuir el estrés - UDEM,
<https://www.udem.edu.mx/sites/default/files/2022-10/Grounding-una-forma-diferente-de-disminuir-el-estr%C3%A9s.pdf>
22. Técnica de Anclaje 5-4-3-2-1,
<https://ucresourcecenter.org/wp-content/uploads/2024/04/Tecnica-de-Grounding-5-4-3-2-1-1.pdf>
23. Nueva Ley Nacional de SALUD MENTAL: Ley 26657 - Comisión Provincial por la Memoria,
https://www.comisionporlamemoria.org/archivos/cpm/normativa/saludmental/ley_nac_salud_mental_26657.pdf
24. Transformación del modelo de atención en salud mental a partir de la ley 26657 - P3 · USAL,
<https://p3.usal.edu.ar/index.php/psicol/article/download/6376/8751/24202>
25. Ley 26657 - LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL - Ministerio Público de la Defensa,
<https://www.mpd.gov.ar/uploads/documentos/Ley%2026657.pdf>
26. DERECHO A LA SALUD ~ SALUD MENTAL ~ LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL ~ ENFERMEDAD MENTAL ~ REPRESENTANTE LEGAL - Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
<https://www.psicologosgcaba.org.ar/wp-content/uploads/Sobre-la-reglamentacion-de-la-Ley-de-Salud-Mental.pdf>
27. Redalyc.INCIDENCIAS DE LA LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL EN LOS DISPOSITIVOS DE GUARDIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS PROFESIONALES,
<https://www.redalyc.org/pdf/3691/369139994057.pdf>
28. PROGRAMA DE ABORDAJE INTEGRAL DE LA PROBLEMÁTICA DEL SUICIDIO - CoPER,
https://www.coper.org.ar/images/legislacion/lineamientos_guias_protocolos/Programa_de_Abordaje_Integral_de_la_problema%CA1tica_del_Suicidio_-_MSAL.pdf
29. Abordaje intersectorial dela problemática del suicidio y de las autolesiones - Biblioteca Nacional de Maestros,

- <https://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL008052.pdf>
30. Centro de Asistencia al Suicida Línea de prevención del suicidio - O.S.C.O.E.M.A,
<http://www.oscoema.com.ar/images/portada/suicidio.pdf>
 31. Guía de recomendaciones para la atención y el acompañamiento a
personas en situaciones de crisis y urgencia - UNER,
<https://uner.edu.ar/archivos/guia-salud-mental.pdf>
 32. Guia-de-Recursos-de-Salud-Mental-y-Adicciones.pdf - Defensoría del Pueblo
CABA,
<https://defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2024/09/Guia-de-Recursos-de-Salud-Mental-y-Adicciones.pdf>
 33. Guia de Recursos CIDAC CORRE.indd,
https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2011/11/Guia_de_Recursos_Zona_Sur_CABA.pdf